

Augenpflege bei sedierten/bewusstlosen Patient:innen

Grundsätzlich:

- intakter Tränenfilm ist bester Schutz für gesundes Auge
- 1x/Schicht Inspektion auf

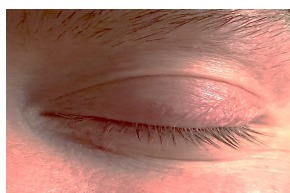


- Lidschluss
- Rötung der Hornhaut +/- Ausfluss
- Trübung der Kornea

MiBi & Ophthalmologie
erwägen

Basis-Pflege

- Ggf. Verkrustungen mit feuchten Kompressen aufweichen und abwischen (geschlossenes Lid - *nie über den Augapfel wischen!*)
- Auge inspizieren



Gruppe 0: Lidschluss intakt

Keine weitere Intervention



Gruppe 1: Konjunktiva sichtbar

Auge ggf. spülen um Salbe zu entfernen,
Augensalbe oder -gel eingeben (alle 4 h)



Gruppe 2: Kornea sichtbar

Wie Gruppe 1, zusätzlich:
Augenlid tapen



Gruppe 3: Bauchlage - wie Gr. 2; vor Umlagern & falls mgl.



Augenpflege bei sedierten/bewusstlosen Patient:innen

Quellen

Ullrich, L. & Stolecki, D. (Hrsg.); „Thiemes Intensivpflege und Anästhesie“; 3. überarbeitete Auflage, Thieme Verlag, 2015; S. 263-266

Universitätsspital Basel; Pflegerichtlinie 1.3.1 Augenpflege; November 2022
<http://bit.ly/3UPNGVI>

Sevgi M, Monachello E, Yates M, Lockington D, Cowan R. Improving eye care in an intensive care unit. Journal of the Intensive Care Society. 2024;25(3):346-349.
doi: 10.1177/17511437241228587
(auch Bildquelle)